

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA COLUMBIA PARA EVALUAR EL RIESGO DE SUICIDIO (C-SSRS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Estandarizada de Ideación y Conducta Suicida

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala Columbia para Evaluar el Riesgo de Suicidio (C-SSRS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)</i>
Autores Originales	Dra. Kelly Posner, David Brent, Cheryl King et al. (2008, 2011), Universidad de Columbia.
Adaptación Española	Al-Halabí et al. (2016); Blasco-Fontecilla et al. (2012). Validación oficial multicéntrica.
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Triage de urgencia y estratificación clínica del riesgo autolítico.
Tipo de Instrumento	Entrevista semiestructurada o cribado clínico asistido con árbol de decisión jerárquico.
Población y Rango	Niños (desde 6 años con versión infantil), adolescentes y adultos. Entornos médicos, escolares y forenses.
Tiempo de Administración	2 a 5 minutos en versión cribado (<i>Screenner</i>); 10 a 15 minutos en versión completa.
Régimen de Licencia	Dominio público científico internacional (The Columbia Lighthouse Project). Uso clínico gratuito.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y ESTÁNDAR C-CASA

La C-SSRS nació por mandato de la Food and Drug Administration (FDA) de los EE. UU. para establecer un léxico universal y estandarizado en la clasificación de acontecimientos suicidas, basado en la taxonomía C-CASA (*Columbia Classification Algorithm of Suicide Assessment*). Tradicionalmente, la falta de una definición unificada entre “pensamientos de muerte”, “autolesión no suicida” e “intento suicida genuino” generaba una enorme confusión asistencial y jurídica.

El modelo de Columbia discrimina con nitidez entre la **Ideación Suicida** (el espectro cognitivo que va desde el deseo pasivo de muerte hasta planes concretos con determinación) y la **Conducta Suicida** (actos preparatorios, intentos interrumpidos o frustrados e intentos consumados), midiendo además la intencionalidad lesiva explícita o inferida. Su uso sistemático se ha convertido en el estándar de oro para predecir conducta suicida futura en servicios de urgencias y salud mental.

3. JERARQUÍA DE LA IDEACIÓN Y CONDUCTA SUICIDA

Nivel de Severidad	Reactivo	Re-spuesta	Definición Fenomenológica Operacional
1. Deseo Pasivo de Muerte	Ítem 1	SÍ / NO	Deseo de estar muerto o no despertar, sin pensamientos de matarse a sí mismo.
2. Ideación Inespecífica	Ítem 2	SÍ / NO	Pensamientos generales de suicidarse sin métodos, plan ni intención declarada.
3. Ideación con Métodos	Ítem 3	SÍ / NO	Piensa en cómo matarse (ej. fármacos, precipitación) pero sin plan concreto ni intención.
4. Intención sin Plan	Ítem 4	SÍ / NO	Pensamientos de matarse acompañados de cierta determinación o intención de actuar.
5. Intención con Plan	Ítem 5	SÍ / NO	Pensamientos con un plan estructurado (lugar, momento, método) y determinación firme.
Conducta Suicida	Ítems 6–10	SÍ / NO	Intentos de suicidio previos, intentos interrumpidos por terceros, intentos frustrados o actos preparatorios (escribir cartas de despedida, acopiar pastillas).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y CAPACIDAD PREDICTIVA EN ESPAÑA

Fiabilidad Inter-jueces	Concordancia entre evaluadores casi perfecta: índice Kappa de Cohen de 0.90 a 0.97 en estudios clínicos españoles (Al-Halabí et al., 2016).
Validez Predictiva Prospectiva	El estudio seminal de Posner et al. (2011) demostró que una respuesta afirmativa en los ítems 4 o 5 multiplica por 8.8 el riesgo de intento suicida a 3 meses.
Validez Convergente	Excelente correlación con la Escala de Ideación Suicida de Beck (BSS, $r = 0.82$) y el módulo suicida de la entrevista MINI.
Capacidad Discriminante	Diferenciación inequívoca entre Autolesión No Suicida (NSSI) y tentativa autolítica genuina con intencionalidad de muerte.
Propiedades en Adolescentes	Alta sensibilidad predictiva validada en unidades infanto-juveniles de hospitalización y urgencias.

5. REGLAS DE APLICACIÓN Y ÁRBOL DE DECISIÓN (SKIP LOGIC)

El protocolo clínico de cribado utiliza una estructura condicional que optimiza el tiempo:

- Se exploran obligatoriamente los **ítems 1 y 2** (último mes o a lo largo de la vida).
- **Regla de Salto:** Si el paciente responde **NO a ambos ítems (1 y 2)**, se pasa directamente a la sección de **Conducta Suicida** (preguntas sobre intentos pasados), omitiendo los ítems 3, 4 y 5.
- **Continuación:** Si responde **SÍ al ítem 2**, deben formularse obligatoriamente los **ítems 3, 4 y 5**.
- La intensidad de la ideación se valora cualitativamente: frecuencia, duración, controlabilidad y disuasores.

6. TRIAJE CLÍNICO DE RIESGO: EL SEMÁFORO DE COLUMBIA

Nivel	Criterio C-SSRS	Estratificación	Conducta y Protocolo de Actuación
Bajo	Ítem 1 o 2 (Sí) Ítems 3, 4, 5 (NO)	Riesgo Leve (Semáforo Verde)	Proporcionar teléfonos de emergencia (024 / 112). Plan de seguridad ambulatorio y seguimiento clínico programado.
Moderado	Ítem 3 (Sí) o intento > 3 meses	Riesgo Moderado (Semáforo Amarillo)	Consulta psiquiátrica preferente. Implicar activamente a familiares, retirar medios letales del hogar y plan de seguridad escrito.
Alto	Ítem 4 o 5 (Sí) o intento < 3 meses	Riesgo Urgente (Semáforo Rojo)	Derivación inmediata a Urgencias Psiquiátricas. No dejar al paciente solo bajo ningún concepto; activar transporte sanitario.

CRITERIO TEMPORAL DE RIESGO CONDUCTUAL: Cualquier acto preparatorio (acopiar medicación, redactar cartas, despedirse) o tentativa acaecida en los **últimos 3 meses** sitúa automáticamente al paciente en **Semáforo Rojo** de alto riesgo inminente, independientemente de que la ideación verbal actual sea baja.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. PROTOCOLO DE SEGURIDAD STANLEY-BROWN

ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN RIESGO MODERADO-ALTO:

1. **Señales de alarma personales:** Identificar pensamientos, emociones o situaciones que anticipan una crisis.
2. **Estrategias de afrontamiento autónomas:** Actividades de distracción que no requieren contacto con otros (caminar, música).
3. **Contactos sociales de distracción:** Lugares públicos o amigos que ayudan a desconectar del sufrimiento.
4. **Red de apoyo familiar/amigos:** Personas a quienes pedir ayuda explícita en crisis.
5. **Profesionales y recursos de urgencia:** Teléfono 024, 112, centro de salud mental de referencia.
6. **Restricción ambiental de medios letales:** Custodia estricta familiar de psicofármacos, armas y objetos lesivos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRIAJE EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

Paciente: Varón de 23 años, estudiante universitario, traído por sus compañeros de piso por conducta de aislamiento extremo y haber dejado una carta con tono de despedida en su habitación tras una ruptura sentimental y suspensión académica. **Evaluación C-SSRS: Semáforo Rojo (Riesgo Suicida Alto e Inminente).** • **Ideación Suicida:** Ítem 1 = Sí; Ítem 2 = Sí; Ítem 3 = Sí; Ítem 4 = Sí (intención declarada); Ítem 5 = Sí (plan de lanzarse al paso del metro la mañana siguiente; determinación firme). • **Conducta Suicida:** Sí en actos preparatorios (redacción de carta de despedida y transferencia de ahorros); niega intentos previos. Ausencia de disuasores afectivos. **Conducta Asistencial:** Se mantiene vigilancia continua 1:1 en sala de observación de urgencias. Se solicita valoración psiquiátrica urgente para formalizar ingreso voluntario en la Unidad de Hospitalización Breve. Se cita a los padres para psicoeducación, contención afectiva y custodia de pertenencias. Tras estabilización farmacológica e inicio de psicoterapia dialéctico-conductual (DBT), a las 3 semanas remite la intencionalidad activa.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD LEGAL Y ASISTENCIAL

ALERTA: OBLIGACIÓN DE NO DEJAR SOLO En pacientes categorizados en Semáforo Rojo (ítems 4 o 5), existe obligación médico-legal de no permitir el abandono del centro sanitario sin supervisión directa. Nunca otorgar alta sin acompañante responsable.

DOCUMENTACIÓN MÉDICO-LEGAL Registrar literalmente en la historia clínica el motivo, nivel del semáforo C-SSRS asignado, medidas de contención ambiental acordadas y presencia de plan de seguridad firmado.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A., ... & Mann, J. J. (2011). The Columbia–Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite clinical trials. *American Journal of Psychiatry*, 168(12), 1266–1277.
2. Al-Halabi, S., Sáiz, P. A., Burón, P., Garrido, M., Benabarre, A., Jiménez, E., ... & Bobes, J. (2016). Validación de la versión en español de la Columbia–Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) en pacientes con trastorno mental grave. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 9(3), 134–142.
3. Stanley, B., & Brown, G. K. (2012). Safety planning intervention: a brief intervention to mitigate suicide risk. *Cognitive and Behavioral Practice*, 19(2), 256–264.
4. Posner, K., Oquendo, M. A., Gould, M., Stanley, B., & Davies, M. (2007). Columbia Classification Algorithm of Suicide Assessment (C-CASA): classification of suicidal events in the FDA's pediatric suicidal risk analysis of antidepressants. *American Journal of Psychiatry*, 164(7), 1035–1043.